

Czym jest *PTSD*

Krótką mapą diagnozy zaburzenia stresu pourazowego. Cztery klastry objawów, jak je rozpoznać u siebie, dlaczego to nie słabość ani charakter, ale fizjologiczna reakcja na zdarzenie.

CZAS: 15 min — przeczytanie Po pierwszej rozmowie diagnostycznej

ŹRÓDŁO: DSM-5-TR (2022); ICD-11 (2022); Foa i wsp. (2007)

JAK UŻYWAĆ

PTSD (ang. *posttraumatic stress disorder*) — zaburzenie stresu pourazowego — to **fizjologiczna i psychologiczna reakcja** na zdarzenie traumatyczne, która utrzymuje się dłużej niż miesiąc i istotnie zakłóca funkcjonowanie. Cztery klastry objawów: **1) nawracające ponowne przeżywanie** (intruzje, flashbacki, koszmary), **2) unikanie** (miejsc, ludzi, myśli związanych z traumą), **3) negatywne zmiany w myśleniu i nastroju** (poczucie winy, izolacja, anhedonia), **4) nadmierne pobudzenie** (czujność, drażliwość, zaburzenia snu). Do diagnozy wystarczy zwykle 1 z klastra 1, 1 z klastra 2, 2 z klastra 3, 2 z klastra 4 — utrzymujące się ≥ 1 miesiąca.

DLACZEGO TO DZIAŁA

PTSD **nie jest oznaką słabości** ani „braku odporności”. To *biologiczna konsekwencja* zdarzenia, które przekroczyło zdolność układu nerwowego do przetworzenia. W normalnym wspomnieniu informacja jest zintegrowana w czasie („wtedy”), miejscu („tam”) i kontekście („to było”). W traumie ten proces zostaje przerwany — wspomnienie pozostaje *żywe, fragmentaryczne, somatyczne*, jak gdyby działa się teraz. Stąd flashbacki. Foa i wsp. (2007) pokazali, że PTSD występuje u **5-10% populacji** w ciągu życia; częściej u kobiet, częściej po przemoc interpersonalnej niż katastrofach naturalnych. Najważniejsze: *PTSD jest leczalne* — nawet po wielu latach. Skuteczne metody: terapia ekspozycyjna (PE), terapia przetwarzania poznawczego (CPT), EMDR.

01

Cztery klastry objawów

B · PONOWNE PRZEŻYWANIE

- Natrętne wspomnienia traumy
- Koszmary (traumie podobne lub niepowiązane)
- Flashbacki — uczucie, że trauma dzieje się teraz
- Intensywna reakcja na wyzwalacze (przypomnienia)
- Reakcje somatyczne na przypomnienia (drżenie, pocenie się)

C · UNIKANIE

- Unikanie myśli i uczuć związanych z traumą
- Unikanie miejsc, ludzi, sytuacji przypominających
- Unikanie rozmów o tym, co się stało
- Wycofywanie się z dotychczasowych aktywności
- Strategia: „jeśli nie myślę, nie boli” (krótkoterminowo działa, długo szkodzi)

D · ZMIANY W MYŚLENIU I NASTROJU

- „To moja wina, że się stało”
- „Świat jest niebezpieczny” / „nikomu nie można ufać”
- Anhedonia, izolacja, poczucie obcości
- Trudność w odczuwaniu pozytywnych emocji
- Luki w pamięci dotyczące zdarzenia

E · NADMIERNE POBUDZENIE

- Czujność na zagrożenie (skanowanie otoczenia)
- Wzmószona reakcja przestrochu
- Drażliwość, wybuchy gniewu
- Trudności z koncentracją
- Bezsennność, sen fragmentaryczny, koszmary

02 Co kwalifikuje jako trauma (kryterium A)

DSM-5-TR definiuje traumę jako *doświadczenie śmierci, poważnego urazu lub przemocy seksualnej* — w jednej z czterech form:

1. Bezpośrednie doświadczenie zdarzenia
2. Bycie świadkiem zdarzenia u innej osoby

3. Dowiedzenie się o zdarzeniu u bliskiej osoby (zwłaszcza nagła / brutalna śmierć)
4. Powtarzana lub ekstremalna ekspozycja na szczegóły traumy (np. praca w służbach ratunkowych)

Typowe wydarzenia: wypadek komunikacyjny, przemoc fizyczna lub seksualna, katastrofa naturalna, działania wojenne, nagła utrata bliskiej osoby, ciężka choroba, poród traumatyczny, doświadczenie medyczne (intensywna terapia), prześladowanie. *Nie każde trudne doświadczenie kwalifikuje się jako trauma kryterialna* — ale nie znaczy to, że nie wymaga uwagi i pracy terapeutycznej.

03 PTSD vs złożony PTSD (C-PTSD)

PTSD KLASYCZNE

Często po *pojedynczym* zdarzeniu lub krótkim okresie (wypadek, napaść, katastrofa). Cztery klastry objawów. Tożsamość pacjenta sprzed traumy zwykle zachowana.

C-PTSD (ICD-11)

Po *długotrwałej, powtarzanej* traumie (przemoc domowa, wykorzystywanie w dzieciństwie, niewola). Cztery klastry + **trzy dodatkowe**: zaburzenia regulacji emocji, negatywne przekonania o sobie, trudności w relacjach.

04 Co działa — terapie pierwszej linii

PE — PRZEDŁUŻONA EKSPOZYCJA

Foa. Stopniowa ekspozycja na wspomnienia traumy + sytuacje unikane. 8-15 sesji. Skuteczność potwierdzona w licznych badaniach.

CPT — TERAPIA PRZETWARZANIA POZNAWCZEGO

Resick. Skupia się na zniekształconych przekonaniach po traumie (wina, zaufanie, kontrola). 12 sesji.

EMDR

Shapiro. Praca z wspomnieniem przy bilateralnej stymulacji (ruchy oczu). Skuteczność zbliżona do PE i CPT.

Klucz: w meta-analizie Bisson i wsp. (2013, Cochrane) terapie traumie-skoncentrowane (PE, CPT, EMDR) miały rozmiar efektu $d \approx 1,2$ — to *bardzo duży* efekt w porównaniu z innymi obszarami psychiatrii. Około **60-80% pacjentów** z PTSD osiąga znaczącą poprawę po 8-16 sesjach. Im wcześniej podjęte leczenie, tym lepsze rokowanie — ale skuteczność nie zanika nawet po latach od traumy. To nie jest stan, który trzeba „przeczekać”.